

## 乙胺碘呋酮（胺碘达隆）的药物相互作用

河北省医学科学院附属医院

徐力飞

胺碘达隆（简称AI）是一种苯并呋喃的衍生物，与其它药物可相互作用。联用后可增加疗效，也可导致不良作用的发生，甚至造成致命性后果。本文就AI的药物相互作用作一综述，供临床参考。

### 1、与双香豆素及其它抗凝血药联用

用双香豆素的患者伍用AI后，可以增强双香豆素的抗凝作用，加速出血的发生。这一作用在联用AI的3~4天即可出现，停用AI后，这一作用可持续数周或数月<sup>[1]</sup>。相互作用的机理可能是AI阻碍了双香豆素的代谢。AI与双香豆素联用，后者需减量1/3~1/2，并需进行凝血酶元时间监测。此外，AI还可以影响肝素的活性。并通过酶的抑制作用，使AI与苧丙酮香豆素合用时，引起后者中毒<sup>[2]</sup>。

### 2、与强心药地高辛联用

地高辛能使潜在性起搏点的自律性增高和Q—T缩短。与AI联用对顽固性快速型心律失常、房扑、房颤的复律和降低心室率有协同作用<sup>[3]</sup>。但由于AI置换了与组织相结合的强心甙或阻断了地高辛的排泄，而易引起洋地黄毒性反应。Moysey等发现AI与地高辛联用3~9天内<sup>[4]</sup>，可使地高辛血浓度平均增加69%。孙氏曾报道AI与地高辛联用，有5例发生室性心动过速<sup>[5]</sup>。其中3例曾作地高辛血药浓度测定，均在治疗范围，提示心律失常的发生并非洋地黄中毒引起。所以如需两药联用时，地高辛用量要减半，也应调整AI的用量。

### 3、与第Ⅰ类抗心律失常药联用

#### （1）与奎尼丁联用

AI能使奎尼丁与蛋白或受体的结合能力发生变化，从而使血清奎尼丁浓度增加<sup>[1]</sup>。奎尼丁可引起Q—T间期延长和扭转型室速，早已受人注意<sup>[6]</sup>。Tartini曾报道两药联用有引起Q—T延长和扭转型室速者<sup>[7]</sup>。再者AI有

延缓传导和抑制各级起搏点的作用，两药联用对心脏的抑制作用叠加，可能是造成窦性停搏等传导阻滞的重要作用。因此若需两药联用时，应用心电图监测Q—T的延长以及测奎尼丁的血清浓度。但孙氏主张对某些顽固性心律失常，单用AI无效的病例，采用AI与奎尼丁联用效果较好<sup>[8]</sup>。

#### （2）与普鲁卡因酰胺联用

此药与AI联用治疗顽固性室速，疗效较佳<sup>[9]</sup>。但相互作用后提高血清普鲁卡因酰胺的浓度<sup>[10]</sup>，这可能是由于AI竞争组织结合部位置换出普鲁卡因酰胺，使其清除率减少的原因。两药联用可影响心室复极，致Q—T显著延长，故应注意引起室速、扭转型室速的可能。

（3）与双异丙吡胺（吡二丙胺）、缓脉灵、安他唑啉、心律平等联用

有人报道AI与吡二丙胺、心律平联用可引起扭转型室速<sup>[7]</sup>，应尽量避免AI与此等药物联用。AI与缓脉灵合用应警惕Q—T间期延长。但孙氏认为AI与安他唑啉联用治疗效果较好<sup>[8]</sup>。

#### （4）与利多卡因联用

利多卡因与AI联用治疗室上性或室性心律失常，有协同增效作用<sup>[3]</sup>。有人报道两药联用亦可引起窦性骤停<sup>[11]</sup>。

#### （5）与慢心律（美西律）联用

美西律可缩短动作电位时间，而AI则延长动作电位时程，两者起协同作用。据文献记载联用治疗顽固性室性心动过速，效果颇著<sup>[9]</sup>。但Tartini等发现联用可引起Q—T延长和扭转型室速<sup>[7]</sup>。

#### （6）与安搏律定联用

安搏律定与AI联用可延长旁路和交界区的长应期，对房性心律失常或预激综合征合并快速心律失常效果显著<sup>[3]</sup>，但联用后能提高安

搏律定的血浓度，合用时安搏律定的剂量应减半<sup>[1]</sup>。

#### (7) 与苯妥英钠联用

此药在高浓度时可抑制传导，与AI联用治疗洋地黄中毒所致的顽固性心律失常较理想，但可引起Q—T延长和扭转型室速，并可直接抑制窦房结导致心脏停搏<sup>3</sup>。

#### 4、与β受体阻滞剂心得安（普萘洛尔）联用

此药可减慢窦率和抑制传导，延长有效不应期，AI有阻滞交感神经作用，但并非β受体的竞争性拮抗物，可减低窦房结的自律性和延长房室结的不应期。凡窦性心动过缓、病窦综合征、不完全性房室传导阻滞者，两药并用更减慢心率，甚至有心脏骤停的危险。Derride曾报告1例在合并AI与地高辛治疗心室率仍很快者，仅口服一次普萘洛尔，即出现心脏停搏<sup>[10]</sup>。孙氏报道两药联用引起完全性房室传导阻滞<sup>[4]</sup>，因此两药联用应慎重。

#### 5、与钙离子拮抗剂异搏定（维拉帕米）、硫氮草酮（地尔硫草）、硝苯吡啶（硝苯啶）联用

AI与此类药均减低窦房结自律性和延缓房室传导作用，AI与异搏定、硫氮草酮联用更减慢窦率或恶化房室传导阻滞，故联用应谨慎<sup>[12]</sup>。但也有人认为AI与硝苯吡啶联用对缓慢性心律失常较为适宜<sup>[8]</sup>。

#### 9、与抗胆碱能药阿托品联用

阿托品能阻滞窦房结的抑制作用，使心率增快，亦可消除迷走神经所致的房室阻滞，对心律较慢的心律失常，两药联用比较安全<sup>[3]</sup>。

#### 7、与β受体兴奋剂异丙肾上腺素联用

此药可增加窦房结和房室结的自律性，加速房室传导，与小剂量的AI联用治疗过缓性心律失常或完全性房室传导阻滞伴心律失常，有一定疗效<sup>[3]</sup>。

#### 8、与全身麻醉药联用

两药联用可发生低血压、房室传导阻滞以及耐阿托品性心动过缓<sup>[11, 13]</sup>。

#### 9、与平喘药氨茶碱联用

AI与氨茶碱的联用仍待探讨。国外有人作实验将盐酸AI和氨茶碱用5%的葡萄糖或生理盐水稀释的溶液，经充分振摇均匀后，都在15分钟产生混浊，在6小时产生明显的白色沉淀<sup>[14]</sup>。从外观看是不能配伍的，应引起临床上注意。

AI为大分子脂溶性药物，对脂肪类食物如牛奶、乳酪等可能有助于此药的吸收。故与脂肪类食物合用时，应注意掌握此药的剂量<sup>[15]</sup>。

总之，胺碘达隆与其它药物的相互作用，目前已受临床关注，还有待于继续研究。

### 参考文献

1. Zipes DP, et al. J Am Coll Cardiol 1981; 8 (4): 1059.
2. 朱毓仁. 医师进修杂志1985; 1: 38.
3. 严序炳, 等. 实用内科杂志1987; 7 (1): 1.
4. Moysey, JO, et al. Br Med J 1981; 282: 272.
5. 孙静平. 中华心血管病杂志1985; 13 (1): 21.
6. Brochier M-Fauchier CR. Arch Med Cœur; 1978; 45: 117.
7. Tartini R, et al. Lancet 1982; I: 1327.
8. 孙静平. 中华心血管病杂志1983; 11 (1): 2.
9. 何培根. 中级医刊1984; 5: 27.
10. Marcus FI, et al. Am Heart J 1983; 106 (4 Part 2): 924.
11. 孙忠实. 中国医院药学杂志1985; 5 (7): 1.
12. 杨俊何. 医师进修杂志1985; 9: 39.
13. 李丙阳. 中国医院药学杂志1985; 5 (6): 10.
14. Duy R, et al. Am J Hosp Pharm 1984; 41 (7): 1379.
15. 陈秋潮. 药学通报1981; 19 (1): 18.